



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I..... 3

PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang..... 3

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Tujuan..... 4

BAB II..... 5

GAMBARAN UMUM..... 5

2.1 Visi..... 5

2.2 Misi 5

2.3 Motto..... 5

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama 5

2.5 SOTK..... 6

BAB III..... 8

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN..... 8

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 8

3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan 10

3.3 Sasaran 10

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 12

BAB IV 13

MONITORING DAN EVALUASI 13

8.1 Monitoring 13

8.2 Evaluasi 13

BAB V 14

PENCATATAN DAN PELAPORAN 14

BAB VI 15

PENUTUP 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit harus melakukan upaya peningkatan mutu dan pelayanan medic baik melalui akreditasi, sertifikasi, ataupun proses peningkatan mutu lainnya.

Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien dimana pada waktu dirumah belum terjadi proses infeksi dan baru muncul saat dilakukan perawatan di Rumah sakit atau infeksi yang terjadi pada tenaga kesehatan. Infeksi Rumah Sakit (IRS) atau HAIs (*Health-care Associated infections*) merupakan masalah serius yang harus dicegah dan dikendalikan sebaik-baiknya. Angka kejadian HAIs terus meningkat antara 1-40% yang berdampak pada peningkatan lama rawat (LOS), biaya perawatan dan resiko morbiditas dan mortalitas. Angka kejadian HAIs meningkat sampai 40% di Asia, Amerika Latin dan Afrika. Oleh karena itu *World Health Organization* (WHO) melalui gerakan *global patient safety challenge* menekankan pentingnya program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI).

Rumah sakit umum melayani populasi pasien yang sangat beragam dengan berbagai tingkat keparahan penyakit. Hal ini meningkatkan risiko transmisi mikroorganisme patogen. Munculnya bakteri resisten antibiotik dan potensi wabah infeksi menuntut adanya sistem pemantauan dan intervensi yang terstruktur. Program PPI ini disusun sebagai acuan kerja komite/tim PPI dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi Kementerian Kesehatan dan standar akreditasi rumah sakit terbaru.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

-
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum
Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit melalui pencegahan, penurunan angka kejadian infeksi, dan perlindungan bagi seluruh penghuni rumah sakit.
2. Tujuan Khusus
 - a. Melaksanakan pemantauan dan pengumpulan data kejadian infeksi terkait layanan kesehatan (HAIs) secara sistematis (Surveilans).
 - b. Memastikan implementasi paket langkah-langkah pencegahan (bundles) secara patuh pada setiap tindakan medis berisiko tinggi untuk meminimalisir kejadian infeksi.
 - c. Menerapkan Kewaspadaan Standar (seperti kebersihan tangan dan APD) serta Kewaspadaan Berdasarkan Transmisi (kontak, droplet, udara) secara konsisten di seluruh area pelayanan.
 - d. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman seluruh staf rumah sakit, pasien, serta pengunjung mengenai prinsip-prinsip PPI melalui program edukasi berkelanjutan.
 - e. Mendukung program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA) dengan memastikan penggunaan antibiotik yang bijak dan sesuai indikasi klinis.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Motto

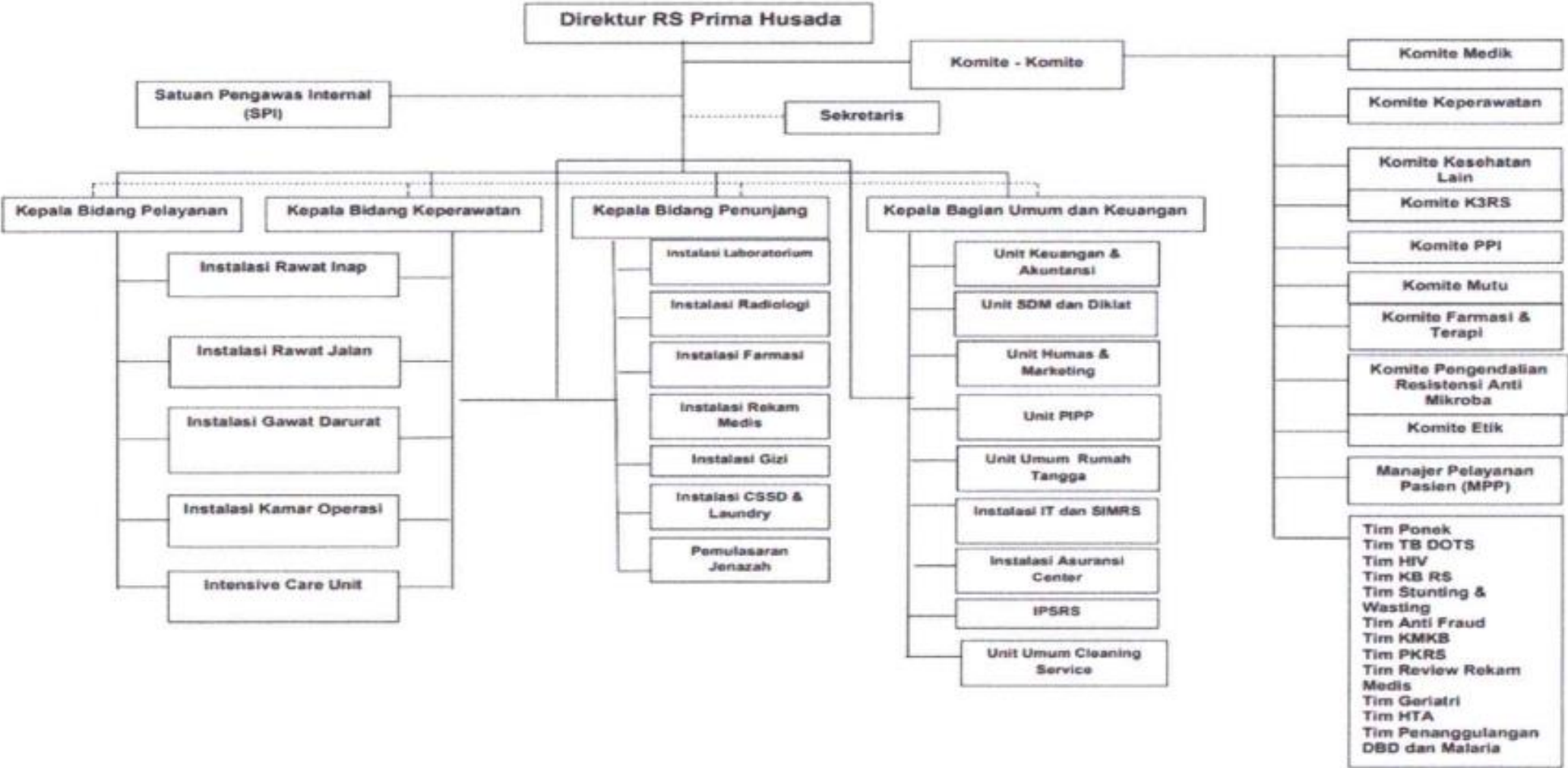
“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

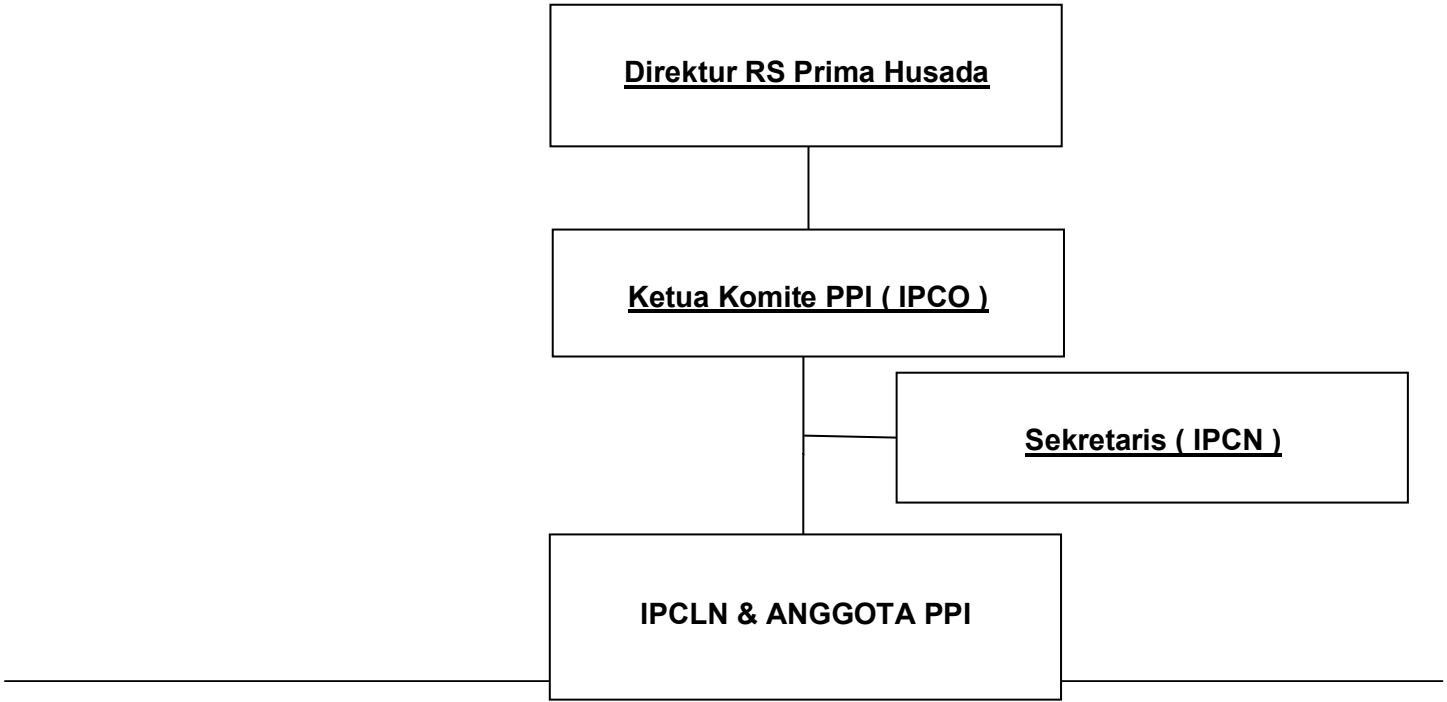
Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur dan dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK



SUSUNAN KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
RS PRIMA HUSADA



BAB III

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Tabel 3.1 Kegiatan pokok dan rincian kegiatan PPI

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Surveilans Infeksi	• Melakukan pengumpulan data harian untuk indikator HAIs (IDO, ISK, PLABSI, VAP). • Melakukan analisis data bulanan, triwulan, dan tahunan. • Melakukan benchmarking data internal dan eksternal. • Melaporkan hasil surveilans kepada Direktur dan Komite Medik.
2	Penerapan Bundles PPI	• Bundle ISK: Melakukan audit kepatuhan pemasangan dan perawatan kateter urin menetap. • Bundle PLABSI: Memastikan teknik aseptik saat pemasangan infus dan perawatan site insersi. • Bundle IDO: Melakukan pengawasan pencukuran rambut (hanya jika perlu), suhu ruang operasi, dan profilaksis antibiotik tepat waktu. • Bundle VAP: Memastikan teknik aseptik saat pemasangan ventilator dan perawatan pasien dengan alat ventilator. • Bundle CLABSI: Memastikan teknik aseptik saat pemasangan vena central dan perawatan site insersi.
3	Kewaspadaan Isolasi	• Melakukan investigasi dan analisis risiko infeksi dengan program mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja (Manrisk) • Membuat Infection Risk Assesment (ICRA) • Monitoring kepatuhan Hand hygiene dan fasilitas kebersihan tangan. • Monitoring penerapan etika batuk. • Monitoring penempatan pasien dan kewaspadaan transmisi.

		• Monitoring berfungsinya ruang isolasi rumah sakit dan penempatan pasien (airborne & immunocompromised) serta proses transfer pasiennya. • Monitoring Kepatuhan Penggunaan APD dan ketersediaan APD. • Monitoring proses pelaksanaan Teknik aseptik. • Monitoring praktek penyuntikan yang aman dan pencegahan cedera karena benda tajam serta perlindungan karyawan. • Monitoring kebersihan lingkungan. • Monitoring manajemen linen. • Monitoring pembuangan sampah infeksius, cairan tubuh, darah, dan benda tajam. • Monitoring kegiatan sterilisasi di rumah sakit termasuk peralatan single use yang di re-use. • Monitoring kegiatan pelayanan makanan • Monitoring kegiatan permesinan • Monitoring pembongkaran, pembangunan dan renovasi • Melakukan investigasi outbreak.
4	Pendidikan dan Pelatihan	Bekerja sama dengan bagian Diklat rumah sakit dalam: • Melakukan diklat internal pada karyawan Rumah Sakit. • In-house training berkala untuk staf medis dan non medis. • Sosialisasi PPI pada karyawan baru. • Menganalisa hasil kegiatan diklat. • Membuat rencana tindak lanjut. • Membuat laporan hasil pelatihan. • Edukasi kepada pasien dan pengunjung melalui leaflet, poster, atau penyuluhan langsung.
5	Penggunaan Antimikroba	• Kolaborasi dengan Farmasi Klinik untuk pemantauan dosis dan durasi pemberian antibiotik. • Monitoring penggunaan antimikroba secara aman.

3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
1	Surveilans HAI's	Pengumpulan data harian pasien berisiko infeksi di unit rawat inap & intensif pada SIMRS terintegrasi mutu.	Sensus	SIMRS Link pelaporan HAI's	Harian & Bulanan.	Laporan bulanan surveilans & grafik tren.	Fokus: IDO, ISK, PLABSI, VAP, CLABSI.
2	Penerapan <i>Bundles</i>	Audit kepatuhan petugas dalam melakukan prosedur medis berisiko.	Audit	<i>Checklist</i> bundle (pemasangan & perawatan).	Harian & Mingguan.	Laporan audit & hasil persentase kepatuhan.	Dilakukan oleh IPCN/IPCLN.
3	Kewaspadaan Isolasi	Monitoring kepatuhan cuci tangan, APD, dan kebersihan lingkungan.	Audit & Monitoring	<i>Checklist</i> audit monitoring kewaspadaan isolasi.	Mingguan & Bulanan.	Laporan hasil audit monitoring PPI.	Dilakukan oleh IPCN.
4	Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggaraan diklat PPI bagi seluruh karyawan dan edukasi pasien.	Edukasi & Sosialisasi	Materi presentasi, leaflet, & poster.	Harian, Tiap Semester/Tahun, Tiap staf baru	Daftar hadir, Pre-Post test, & Sertifikat.	Termasuk orientasi karyawan baru dan edukasi pasien dan pengunjung.
5	Penggunaan Antimikroba	Review penggunaan antibiotik pada resep pasien dan profilaksis bedah.	Audit Kuantitas & Kualitas	Formulir Gyssens & data farmasi.	Tiap 3-6 Bulan.	Laporan pola kuman & audit antibiotik.	Kerjasama dengan Komite Farmasi & Terapi.

3.3 Sasaran

1. Semua staf di area rumah sakit termasuk dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk pula semua orang yang berada dan melakukan aktifitas di rumah sakit yaitu tenaga kesehatan (medis dan non medis), tenaga non kesehatan (house keeping, satpam, tukang parkir, kantin dan lain-lain), pasien, keluarga pasien dan pengunjung.
2. Semua area di rumah sakit termasuk dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi yaitu area pelayanan pasien (rawat inap, rawat jalan, Laboratorium, CSSD, Laundry, Gizi, Farmasi, kamar jenazah dll) dan non pelayanan pasien (Rekam medik, sanitasi, keuangan, kepegawaian dll) serta fasilitas umum (ruang tunggu, parkir, kantin dll).

3. Rincian sasaran kegiatan:

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Surveilans Infeksi	Memantau & menurunkan angka HAI's. • Angka IDO • Angka IADP • Angka VAP • Angka ISK • Angka Phlebitis • Angka Decubitus	• Pasien rawat inap & intensif.	Data (Laporan)	• IDO ≤2% • IADP ≤3,5‰ • VAP ≤5,8‰ • ISK ≤4,7‰ • Phlebitis ≤5% • Decubitus 0%	• Angka IDO, ISK, PLABSI, VAP ≤ standar.	PIC Data (IPCLN) Audit oleh IPCN.
2	Penerapan bundles	Mencegah infeksi pada tindakan invasif.	• Dokter & Perawat di unit terkait.	Data (Audit)	• 100% Kepatuhan.	• Kepatuhan bundle harian tercapai.	Observasi langsung.
3	Kewaspadaan isolasi	Memutus rantai penularan infeksi di Rumah Sakit.	• Seluruh staf, pasien, & pengunjung.	Data	• ≥85% Kepatuhan.	Angka kepatuhan meningkat dan mencapai standar.	SK Komite PPI dan Monitoring Kewaspadaan isolasi
4	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan kompetensi PPI.	• Karyawan (Medis/Non-medis) & Outsourcing.	Sertifikat & Daftar Hadir	• 100% Karyawan terlatih.	• Nilai post-test rata-rata ≥80.	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
5	Penggunaan Antimikroba	Mencegah resistensi antibiotik.	• Dokter (DPJP) & Farmasi.	Data	• Kualitas Gyssens kategori I.	• Penurunan penggunaan antibiotik profilaksis > 24 jam.	Kolaborasi dengan PPRA.

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Surveilans HAIs	Pasien Rawat Inap & Intensif	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Seluruh Unit Pelayanan	IPCN	RS	Pemantauan harian.
2	Penerapan Bundles	Dokter & Perawat	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Unit Terkait (OK, ICU, IRNA, IGD, dll)	IPCLN / Ka. Unit	RS	Fokus pada tindakan invasif.
3	Kewaspadaan Isolasi	Staf, Pasien, Pengunjung	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Seluruh Area RS	IPCN / K3RS	RS	-
4	Pendidikan & Pelatihan	Karyawan Medis & Non-Medis, staf baru							☑						Ruang Pertemuan / Diklat	Bagian Diklat & PPI	Anggaran Diklat	Pelatihan berkala & orientasi.
5	Penggunaan Antimikroba	Komite Medik & Farmasi						☑						☑	Komite Medik / Farmasi	Ketua KPRA / PPI	RS	Audit Gyssens & DDD.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

8.1 Monitoring

Monitoring adalah proses pengawasan rutin saat kegiatan sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi masalah secara dini.

- Audit Kepatuhan: Melakukan observasi langsung (seperti audit kebersihan tangan atau penggunaan APD) secara berkala di setiap unit.
- Surveilans Harian: Pengumpulan data kejadian infeksi (HAIs) yang dilakukan oleh IPCLN dimonitoring oleh IPCN (Infection Prevention and Control Nurse).
- Monitoring Fasilitas: Memastikan ketersediaan logistik PPI seperti sabun cuci tangan, handrub, dan ketersediaan APD di gudang maupun unit.

8.2 Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program dilaksanakan pada akhir tahun.

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah target yang ditetapkan di awal (pada Bab Sasaran) telah tercapai.

- Analisis Data: Membandingkan hasil surveilans dengan standar nasional atau pencapaian bulan sebelumnya.
- Rapat Koordinasi: Pertemuan bulanan Komite PPI untuk membahas hasil temuan monitoring dan mencari solusi atas kendala yang ada dan rapat triwulan dengan komite lain termasuk mutu.
- Dokumentasi kegiatan dilakukan pada saat akhir kegiatan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi TOR, Laporan pelaksanaan, UMANDOK.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS Prima Husada tidak bisa diwujudkan hanya dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan saja, akan tetapi dibutuhkan upaya peningkatan sistem dan pemikiran yang holistik. Evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilakukan di semua unit kerja.

b. Pencatatan:

- Setiap unit melakukan pencatatan harian menggunakan formulir surveilans di SIMRS dan formulir audit monitoring kepatuhan.
- IPCN merekapitulasi data tersebut ke dalam laporan bulanan dan melakukan Analisa serta membuat rencana tindak lanjut perbaikan.

c. Pelaporan

- Laporan Bulanan: disusun oleh IPCN untuk diserahkan kepada ketua Komite PPI dan direktur.
- Laporan triwulan: disusun oleh ketua komite PPI diserahkan kepada direktur dan dilaporkan pada komite PMKP.
- Laporan Tahunan: disusun oleh ketua komite PPI diserahkan kepada direktur.
- Laporan Eksternal: Pelaporan data HAIs ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Mutu Fasyankes atau ketersediaan data untuk akreditasi (STARKES).

d. Tindak Lanjut Evaluasi

- Hasil evaluasi yang tidak mencapai target akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan.

BAB VI PENUTUP

Program ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi RS Prima Husada Malang. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan mutu pelayanan RS Prima Husada Malang melalui Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Malang, 26 November 2025
Ketua Komite PPI



dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Disusun oleh,
IPCN/Sekretaris Komite PPI



Sherly Rosita, S. Kep. Ns

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes